

AFMCP 4장 — 임상검진 Part2 핵심 요약

피부 검진 | Dr. Elizabeth Boham

피부 소견 → 영양소 빠른 참조표

- 건조 피부 (Xerosis): EFA, 아연, 비타민 A·C·B
- 모공각화증 (팔 뒤 오돌토돌): EFA, 아연, 비타민 A
- 지루 피부염 (기름진 비늘): B6·리보플라빈·B12·비오틴·아연·구리; 효모 과성장
- 여드름 + 손발톱 백점 + 모공각화증: → 아연 부족 (3종 세트)
- 여드름 + 모공각화증만: → 아연 + 비타민 A 병행 고려
- 습진, 거친 피부, 상처 치유 지연: EFA (오메가-6·오메가-3) 부족
- 백조 목 모발, 모낭 자반: 비타민 C 부족
- 피부 과도 멍, 점상출혈: 비타민 C + K 결핍, 바이오플라보노이드 부족
- 건선 (Psoriasis): 비타민 A·D, EFA, 담즙 부족; 장 투과성 ↑
- 심한 모낭 각화증 (Phrynoderma): 비타민 A 심각 결핍
- 지단피부염 + 탈모 + 설사 + 낮은 ALP: 아연 결핍 (장성 지단피부염 의심)

3종 세트 패턴

여드름 + 손발톱 백점 + 모공각화증 → 아연 결핍

탈모 + 피부 발진 + 낮은 ALP + 설사 → 아연 부족 (심각 시 장성 지단피부염)

EFA 식이 공급원

- 오메가-6 (리놀레산): 견과류, 씨앗, 식물성 기름
- 오메가-3 (ALA): 아마씨, 치아씨드, 연어, 정어리, 호두

여드름 통합 평가 체크리스트

- 식이: 고단순당·염증성 식이·유제품 여부
- 체성분: 허리/엉덩이 비율, 내장지방
- Phase Angle: 낮으면 세포막 손상 → 지중해식 순응도 감소
- 영양소 보충: EFA·아연·셀레늄·비타민 A·C·E·B6·판토텐산

핵심 임상 메시지

- 피부 검진은 악수 때부터 시작 — 손의 질감과 건조 정도를 즉시 확인
- 비타민 C는 매일 섭취가 필수 (인체는 합성 불가)

- 담즙 부족이 건선과 연관 → 담즙산염 보충 시도 가능
- 영양사·헬스 코치와의 팀 접근이 피부 치료에 효과적